

电击头面部他杀 1 例

童 昉¹, 张 健², 梁 悦¹, 李文鹤¹, 杨 怡¹, 张 琳¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 邵阳市公安局双清区分局刑警大队, 湖南 邵阳 422000)

关键词: 法医病理学; 电击伤; 杀人

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.03.024

文章编号: 1004-5619(2017)03-0316-02

1 案 例

1.1 简要案情

梁某, 女, 40 岁, 不明原因失踪约半个月后被发
现死于自家床上, 尸体已高度腐败。

1.2 尸体检验

尸表检查: 尸体高度腐败, 呈巨人观。

尸体解剖: 双耳垂及右前额见小片状表皮剥脱,
中央区域凹陷, 触之质硬, 沿前额发际下、双侧耳廓及
下颌切割面部皮肤并剥除, 口唇及鼻部周围未见出血。
颈部肌肉分层解剖未见出血。剖开胸腔腔, 全身各重
要器官(脑、心、肺、脾、肝、双肾)不同程度腐败。

组织病理学检验: 右前额部分表皮层及真皮浅层
脱落, 可见炭化组织, 残存部分表皮细胞融合、致密,
界限不清, 真皮附属器细胞核变细长, 呈极化改变, 形
成核流或钉状突起(图 1)。肺水肿显著, 灶性肺出血;
部分心肌呈碎片状断裂, 可见灶性肌溶解或收缩带坏
死(图 2), 心肌间质未见炎症细胞浸润, 冠状动脉右
主干见一孤立性 II 级粥样斑块, 传导系统自溶。

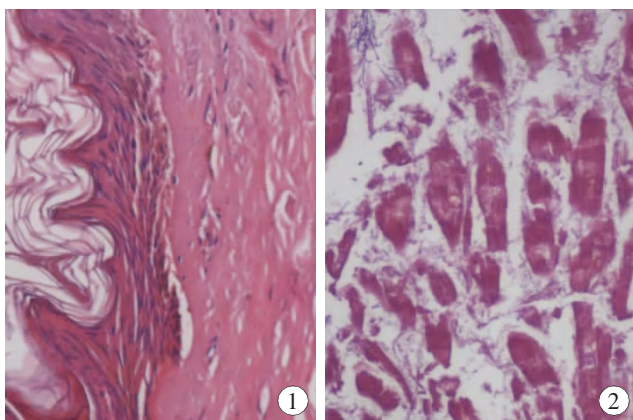


图 1 左前额电流斑 HE×200; 图 2 心肌收缩带坏死
或灶性肌溶解 HE×400

毒物检验: 死者血液、尿液中均未检出常见毒(药)
物成分。

法医病理学诊断: (1) 头面部多处电流斑; (2) 冠状
动脉右主干孤立性 II 级粥样斑块形成; (3) 肺水肿, 灶
性肺出血; (4) 多器官腐败自溶(脑、心、脾、肝、双肾)。

2 讨 论

在法医学实践中, 电流损伤较为多见且多为意外
及灾害事故^[1], 而电击他杀则极为罕见^[2]。

电击他杀属排除性诊断, 法医工作者首先需排除
其他致死可能(如中毒、机械性损伤或机械性窒息)。
本例死者体表未见致死性机械性损伤, 血液、尿液中
均未检出常见毒(药)物成分, 基本可以排除机械性损
伤或毒物直接致死的可能。然而, 由于行尸体检验时
尸体已呈巨人观, 部分轻微损伤(如皮下出血或挫伤)
难以观察, 虽然死者颈部诸肌群未见出血, 但仍然无
法排除其因口鼻部受捂压窒息的可能。因此, 办案人
员在经被害人家属同意的情况下, 将其面部皮肤剥除,
口鼻周围肌群未见出血, 排除了因捂压口鼻部引起窒
息的可能。

秦志强等^[3]认为, 皮肤电流斑系电击死的重要诊
断依据, 对于该类案件的死因鉴定具有重大意义。本
案中, 死者头面部有多处表皮剥脱伴中央区域凹陷,
组织病理学检验符合电流斑形态学改变。

一般认为, 人在受到电击时, 电流通过心脏, 导致
心电功能紊乱, 部分心肌坏死, 最终引起心功能衰竭^[4]。
Fineschi 等^[4,5]研究发现, 电击可引起心肌断裂、间质
出血或收缩带坏死等病变。本例死者部分心肌呈碎片
状断裂, 并检见灶性肌溶解或收缩带坏死, 而冠状动
脉检查仅发现右主干孤立性 II 级粥样斑块形成。因
此, 结合死者头面部所检见的电流斑, 综合分析认为,
死者系头面部(前额、双耳垂)受到电击致死。

经调查, 死者生前常因琐事与丈夫发生争执。某
日夜晚, 其丈夫在家中趁其熟睡时用电线长时间电击
其前额及双耳垂。发现梁某死亡后, 其丈夫逃亡。上述
调查结果与本案鉴定意见一致。

作者简介: 童昉(1989—), 男, 硕士研究生, 主要从事法医病理
学研究; E-mail: drtongfang@163.com

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医
病理学研究; E-mail: 450654925@qq.com

参考文献:

- [1] 赵子琴. 法医病理学[M]. 第4版. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 352.
- [2] Liu S, Yu Y, Huang Q, *et al.* Electrocution-related mortality: a review of 71 deaths by low-voltage electrical current in guangdong, china, 2001-2010[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2014, 35(3): 193-196.
- [3] 秦志强, 龚毓昌, 黄晓华. 电击伤组织的超微结构观察[J]. *法医学杂志*, 2001, 17(3): 142-144.
- [4] Fineschi V, Karch SB, D'Errico S, *et al.* Cardiac pathology in death from electrocution[J]. *Int J Legal Med*, 2006, 120(2): 79-82.
- [5] Fineschi V, Di Donato S, Mondillo S, *et al.* Electric shock: cardiac effects relative to non fatal injuries and post-mortem findings in fatal cases[J]. *Int J Cardiol*, 2006, 111(1): 6-11.

(收稿日期: 2015-06-03)

(本文编辑: 邹冬华)

急性乙醇中毒基础上干性溺死 1 例

鄧 毅¹, 叶光华^{2,3,4}, 陶陆阳², 范琰琰^{3,4}, 喻林升^{3,4}

(1. 白银市公安局白银区分局, 甘肃 白银 730900; 2. 苏州大学医学部法医学系, 江苏 苏州 215006; 3. 温州医科大学司法鉴定中心, 浙江 温州 325027; 4. 温州医科大学法医学系, 浙江 温州 325035)

关键词: 法医病理学; 急性乙醇中毒; 干性溺死

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.03.025

文章编号: 1004-5619(2017)03-0317-02

1 案 例

1.1 简要案情

李某, 男, 67岁, 平素健康, 但喜欢饮酒, 而且经常喝醉。某年1月9日李某在家喝了一些白酒, 当晚18:00参加同学女儿婚宴, 又喝了酒, 21:20离开酒店独自步行回家。第2天早上9:00许有市民发现某湖面有件大衣, 后又在湖中发现尸体, 遂打110报警。民警赶到现场, 调取酒店到湖边所有监控, 证实李某离开酒店后手拿着一件黑色羽绒大衣, 呈醉酒步态行走, 路过该湖边时, 不慎跌落湖中后死亡。

1.2 现场勘验

湖面长39.2m、宽11.3m, 水深2.8m, 湖面结有薄冰, 湖水清澈, 湖水温度0℃左右, 湖岸无围栏, 湖岸距水面的高度0.7m。尸体离岸边0.5m, 呈头朝下、俯卧位, 半浮在水中, 尸体头部离水面2.0m, 腿部离

水面1.4m; 面部未见苦笑面容; 口、鼻周围未见蕁样泡沫; 双侧手指呈抓物状, 其中右手抓住少许湖中的垃圾; 尸体上穿背心及褐色花格纹毛线衣, 下穿短裤及蓝色长裤, 脚穿灰色袜子及黑色皮鞋。尸体附近水面漂浮一件黑色羽绒大衣。提取现场水样进行硅藻检验。

1.3 尸体检验

死后2d进行系统尸体检验。

尸表检查: 尸体未见明显腐败, 尸斑较淡, 呈淡红色, 分布在头面部; 尸长159.0cm, 发育正常, 体型偏胖, 营养中等; 全身皮肤可见鹅皮样外观, 双手呈洗衣妇手改变; 双眼睑、球结膜均可见细小出血点, 双侧瞳孔等大等圆, 直径0.5cm; 口唇发绀, 牙关紧闭, 舌尖及舌边缘可见咬痕; 口、鼻腔内未见明显异物; 尸表除了左膝关节皮肤见少许擦挫伤外, 未见任何损伤。

尸体解剖: 硬脑膜外、下均未见出血、血肿, 脑质量1547g, 呈淤血、水肿状, 未见蛛网膜下腔出血, 脑动脉及基底动脉环未见畸形, 脑切面未见出血、挫伤、肿瘤等, 各脑室未见积血; 喉头稍水肿; 双侧扁桃体轻度肿大; 咽喉部、气管腔未见明显溺液及其他异物; 肺膜可见点、片状出血, 未见肋骨压痕, 未见明显的水性肺气肿改变; 心脏质量268g, 心外膜可见细小点状出血, 各瓣膜均未见狭窄及关闭不全, 主动脉、肺动脉管

基金项目: 法医病理学教学改革的研究与实践资助项目(YBJG 201520)

作者简介: 鄧毅(1978—), 男, 主要从事法医临床学和法医病理学鉴定; E-mail: zwq780818@126.com

通信作者: 叶光华, 男, 博士研究生, 主要从事法医病理教学、科研、检案; E-mail: yeghua345@126.com

通信作者: 陶陆阳, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医学教学、科研和检案工作; E-mail: taoluyang@suda.edu.cn